

× ニューモシスチス肺炎の病態には宿主の免疫が大きく関与しており、免疫応答が強い非ヒト免疫不全ウイルス患者の方が予後が悪い。

× ボリコナゾールは主に肝臓の CYP2C9 や CYP3A4 により代謝される。
リファンピシンと併用した場合、代謝酵素の誘導により代謝が亢進し血中濃度が低下し治療効果が得られないため、併用禁忌である。

× 新たな薬剤による単独療法となる可能性が高く、その薬剤への耐性を誘導する危険性があるため禁忌である。

× イソニアジドとリファンピシンが減感作療法の対象となる。

× イソニアジドによって体内でのヒスタミンの蓄積が生じうるため、マグロ、ブリ、ハマチなどは控える。また、チーズなどに含まれるチラミンも蓄積しやすいため、控えるべきと報告されている。

○ ミトコンドリア遺伝子 1555A → G 変異との関連が報告されているため、家族歴の聴取が重要である。

○

○ 感染症法の規定に則り、発生届および公費負担申請書を保健所へ提出する。

× 耐性を誘導する可能性があり、クラリスロマイシンの単剤投与は推奨されていない。

○ 2020 年にガイドラインが改訂された。用量に注意が必要である。

× 適応は肺 MAC 症に対する多剤併用療法による前治療において、効果不十分な患者に限定されている。

× 一般的な薬剤治療期間は排菌陰性化後 1 年間が望ましいとされている。

× 重症化リスク因子を有し、酸素投与を要しない患者を対象に投与を行うよう推奨されている(2021 年 12 月時点)。

V